

03 - 3 Relation médecin malade

Bonjour, aujourd'hui on va voir la relation médecin-malade. A la fin de ce cours, vous devez être capable de définir la santé selon l'OMS, préciser le rôle et le statut de médecin du malade, citer les types de relations médecin-malade, reconnaître les caractéristiques de cette relation, définir le transfert et le contre-transfert, reconnaître les différents types du contre-transfert et reconnaître l'attitude à avoir devant certaines situations cliniques pratiques. La santé selon l'OMS est définie par un état de complet bien-être physique, mental et social et pas seulement une absence de maladies ou d'infirmités.

Il faut les trois. Rappelez-vous, la dernière fois, on a dit qu'il faut prendre le patient dans sa globalité, traiter l'état physique, traiter l'état mental et traiter aussi s'il a des problèmes sociaux, problèmes d'intégration, problèmes d'adaptation sociale. Les droits et les devoirs, ce sont les attentes et les rôles du médecin par rapport au malade ou bien du malade par rapport au médecin.

Parmi les droits de malade, il y a l'exemption de la responsabilité face à la maladie. Le malade n'est pas responsable de sa maladie, quelle que soit la maladie. Un diabétique n'est pas responsable de sa maladie, un patient cardiaque n'est pas responsable de la maladie, un patient qui a un HIV n'est pas responsable de sa maladie, un patient qui est addict à l'alcool n'est pas responsable de sa maladie.

Le patient aussi a le droit à l'arrêt maladie, il a le droit à l'aide et au droit aux soins. Parmi les obligations du patient, il y a l'obligation de coopérer et l'obligation de désirer guérir. Sauf dans deux cas, bien sûr, c'est le cas des malades mentaux.

On sait qu'ils sont inconscients de leur maladie. En général, ils refusent les soins. Il y a aussi le cas des enfants.

Parmi les devoirs du médecin, le médecin doit avoir une formation médicale continue, être à jour sur les nouvelles techniques, les nouveaux médicaments à prescrire. Il doit avoir une attitude universaliste par rapport au sexe, à l'âge, à la race et à la religion des patients, ne pas faire de différence. Il doit aussi ne pas profiter du malade.

Il doit aussi avoir une neutralité affective tout en gardant une empathie. C'est-à-dire qu'il ne doit pas s'identifier à 100% avec le patient. Il ne doit pas souffrir avec le patient.

Si le patient, par exemple, pleure devant lui, souffre devant lui, le médecin ne doit pas souffrir avec le patient. Il doit garder cette neutralité affective tout en étant empathique. L'empathie, c'est la capacité à pouvoir se mettre à la place de l'autre pour comprendre sa souffrance.

Bien sûr, il doit y avoir un désintéressement par rapport à l'argent. Les honoraires d'un médecin sont connus. Les médecins doivent respecter ce qui est prescrit.

Parmi les devoirs du médecin, c'est le respect du secret professionnel. Il ne doit pas divulguer le secret professionnel à personne, sauf cas exceptionnels. Lorsque c'est demandé par un juge ou bien par un tribunal, bien sûr, on va l'écrire dans un courrier confidentiel.

C'est le cas le plus souvent des enfants avec sévices. Des fois, quand on hésite, on va se poser la question où se trouve l'intérêt du malade. Je vous laisse lire le serment d'Hippocrate.

Vous allez retrouver des choses qui vont gérer cette relation médecin-malade et la relation entre les médecins aussi. Le médecin, pour avoir une bonne relation avec son malade, doit rester au même niveau scientifique du malade en expliquant par exemple la maladie, en expliquant le traitement et doit respecter le niveau scientifique du malade. On n'explique pas les choses de la même façon à un patient analphabète ou bien qui n'a pas de niveau d'instruction comme un patient qui a par exemple un niveau d'instruction élevé.

Donc l'explication, elle doit suivre, aller vers le niveau scientifique du patient. Donc le même niveau affectif, comprendre la souffrance du patient. Niveau juridique, le médecin doit informer le patient sur des risques des fois par rapport à la maladie, par rapport à la non prise de médicaments, par rapport à son comportement.

On va parler au niveau de ce cours de deux notions importantes, le transfert et le contre-transfert. Le transfert, c'est l'ensemble des sentiments qu'a le patient envers son soignant. Le contre-transfert, c'est le vécu du soignant envers le patient.

Ces deux notions, elles sont gérées par ce qu'on appelle le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir, c'est les connaissances théoriques que vous avez. Le savoir-faire et le savoir-être, c'est comment vous allez les appliquer, ces connaissances théoriques.

C'est votre pratique, comment vous allez examiner le malade, comment vous allez donner l'information au patient, comment vous allez expliquer le diagnostic au patient et comment vous allez prendre soin de votre patient. Selon Hollandaire, la relation médecin-malade est définie par trois types de relations. Le premier, c'est la relation activité-passivité.

C'est le modèle mère-nourrisson. Dans ce type de relation, le patient est passif à 100%, la participation du patient est de 0% et le médecin est actif à 100%. C'est le cas des patients comateux, des patients qui subissent une intervention chirurgicale.

Et il y a la relation de guidance-coopération. C'est le modèle parent-enfant. Les parents guident les enfants et les enfants doivent coopérer.

C'est le cas des maladies fébriles, les fractures osseuses par exemple. Le médecin va donner des consignes et le malade va suivre ces consignes. Le troisième type de relation, c'est la participation mutuelle et réciproque, 50%, 50%.

C'est le modèle adulte-adulte. Ceci, on le trouve dans les maladies chroniques ou bien les réadaptations post-opératoires. Dans ce type de pathologie, des fois, on ne voit le malade que deux fois par an ou bien tous les trois mois, tous les quatre mois.

Entre temps, c'est le patient qui fait la prise en charge. Parmi les caractéristiques de cette relation, on note le fait que c'est une relation d'inégalité. Le patient est dans la souffrance, il est affaibli par sa souffrance et le médecin est dans une position de force.

Une relation d'attente et d'espérance des deux côtés. Le malade attend la guérison et espère la guérison. Le médecin attend aussi la guérison de son patient et espère l'amélioration de l'état de son patient.

C'est une relation de corps comme objet mais qui passe par la parole. C'est le corps qui souffre, mais la parole, c'est ce qu'exprime le patient. Le langage du corps est celui que comprend et accepte le médecin.

Le langage du corps est celui que comprend le malade. C'est pour ça que des fois, les malades, quand ils n'arrivent pas à exprimer leur souffrance psychique verbalement, ils vont l'exprimer par le corps, par la somatisation, donc par des signes physiques. Ils vont venir se plaindre de douleurs, par exemple, au niveau abdominal, ou bien par des céphalées, ou bien par des palpitations, ou bien par des gênes respiratoires, parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer verbalement et parce qu'ils se disent que le médecin ne comprend que le langage du corps.

Donc, ils vont transformer leur souffrance psychique en souffrance corporelle que va comprendre le médecin. La relation thérapeutique-médecin-malade est déterminée par de nombreux facteurs individuels et socio-culturels. De même que le malade réagit à sa maladie en fonction de sa personnalité propre, le médecin réagit face à son malade par des attitudes conscientes et inconscientes en fonction de sa personnalité, de son histoire, ce qui peut infliger le cours de la relation thérapeutique.

On va le voir par la suite dans les différents types du contre-transfert. C'est une relation fondamentale fondée sur l'inégalité. La demande du patient le rend passif et dépendant du médecin et sa souffrance le mobilise et le diminue.

C'est une relation d'attente et d'espérance mutuelle. Le malade attend la guérison ou au moins le soulagement, le soignant, et attend la reconnaissance de son pouvoir réparateur. C'est une relation où le lien d'échange est avant tout le corps, mais où la parole a sa place.

C'est une relation de confiance, comme on a dit, non égalitaire. La théorie psychanalytique dans cette relation a défini le concept de transfert et de contre-transfert. Comme on a dit la dernière fois, le contre-transfert, le transfert c'est une réaction affective, consciente et inconsciente qui prouve le patient à l'égard de son médecin.

Donc ça peut être conscient ou inconscient. Le contre-transfert c'est les réactions affectives, conscientes et inconscientes aussi qui prouvent le médecin vis-à-vis de son patient. Ce contre-transfert est très directement lié à la personnalité et à l'histoire du personnel du médecin.

Donc ce que vous allez, en tant que médecin, ressentir par rapport à votre patient, ça va être en fonction de votre histoire et en fonction de vos antécédents et en fonction de votre personnalité. Le plus souvent, le contre-transfert est positif. En général, vous allez avoir un contre-transfert positif avec votre patient.

Ce contre-transfert positif va permettre une relation médecin-malade de qualité, une empathie du médecin par rapport à son malade et bien sûr, ça va donner une action thérapeutique efficace. Donc il faut un contre-transfert positif. Une relation médecin-malade de qualité signifie que le médecin a un contre-transfert excessivement positif risque de conduire à une identification massive au malade et ou à une perte d'objectivité dans les soins.

Si par exemple, vous êtes devant un patient et vous vous identifiez à lui, vous ne pouvez pas prendre des décisions médicales ou bien des décisions correctes pour ce patient. Par exemple, si vous êtes devant un patient, vous le prenez pour votre fils par exemple, là vous ne pouvez pas être objectif pour voir s'il a besoin d'une intervention chirurgicale, s'il a besoin de faire un bilan invasif, s'il a besoin de prendre un traitement lourd, vous ne pouvez pas prendre une décision. Donc il faut toujours garder une certaine distance affective par rapport au patient, ne pas s'identifier massivement au patient pour pouvoir prendre des décisions objectives.

Un contre-transfert négatif induit de l'agressivité des frustrations excessives du malade et peut être à l'origine d'échecs de la relation thérapeutique. Donc lorsque vous ne prouvez aucune empathie par rapport au patient, ça peut conduire à un contre-transfert négatif. Je vous donne un exemple.

Imaginez par exemple, vous avez été agressé par un sujet et le lendemain vous êtes de garde aux urgences, vous rencontrez soit le même sujet, soit un sujet qui lui ressemble, un patient qui lui ressemble. Alors comment vous allez être ? Donc je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut parler d'un contre-transfert négatif. Donc en tant que médecin, normalement vous devez gérer votre réaction, vous devez essayer de vous calmer, essayer de vous adapter, donc essayer de faire votre rôle et de faire votre métier, d'avoir ce savoir-être et ce savoir-faire et rappelez-vous le serment d'Hippocrate, vous ne devez pas faire de différence, quel que soit le malade.

L'absence de contre-transfert peut conduire aussi à une froideur excessive. Balint, docteur Balint, c'est un psychanalyste anglais qui a développé une modalité originale d'approche de la relation médecin-malade. Ses travaux sont issus de quelques constatations qui sont, il existe un certain nombre d'insuffisances de la médecine traditionnelle.

La médecine traditionnelle, rappelez-vous la dernière fois, on a dit qu'il ne s'intéresse qu'à

l'organe et qu'il étudie plus les maladies que les malades. Alors la médecine moderne, on étudie le malade dans sa globalité. Alors, le médecin en lui-même peut être un remède en soi par son savoir-faire et son savoir-être.

Même si son action est médiatisée par un médicament, mais par son savoir-faire et savoir-être, s'il est bien fait, il peut aider à améliorer le sujet avant même que le patient commence à prendre les médicaments. Un tiers de l'activité professionnelle d'un médecin généraliste ne relève que d'une action psychothérapeutique. Les groupes BALINT sont consacrés à l'approche en groupe des diverses problématiques relationnelles médecin-malade.

Donc au niveau des services, on fait des réunions de façon régulière pour discuter les problèmes personnels entre l'équipe. La relation médecin-patient est actuellement en pleine mutation. Dans notre société, on souhaite faire évoluer la relation médecin-patient d'un modèle paternaliste vers un modèle d'autonomie.

Le modèle paternaliste, c'est le modèle où le médecin décide de tout. Le modèle d'autonomie, on a le médecin qui va inciter le patient à prendre des décisions aussi avec lui. Les nouvelles obligations liées à l'information et au consentement éclairé du patient concernant les soins exigent le passage à ce modèle d'autonomie.

Les médecins devront trouver un juste milieu entre deux pôles extrêmes. Le premier pôle, la relation dite paternaliste, trop inégalitaire, respectant insuffisamment l'individu parce que le médecin décide de tout, donc c'est un manque de respect pour le malade, trop peu concerté et informé des traitements, donc on ne prend pas l'avis du patient, on ne prend pas l'accord du patient pour le traitement. Ça, c'est le modèle paternaliste.

Le second pôle correspond à une relation dite d'autonomie. Le médecin se déresponsabilise de toute décision. Le patient est censé être capable de prendre les meilleures décisions pour lui-même dans les domaines aussi difficiles que sa maladie ou sa mort, par exemple.

Donc il faut impliquer le malade dans la prise de décision par rapport au traitement, par rapport aux soins. En pratique, et pour respecter le patient sans se dédouaner de son rôle, le médecin se devra expliquer sa maladie au patient en adaptant son langage à celui du patient. On a dit tout à l'heure qu'il faut avoir le même niveau scientifique.

La communication du dossier médical devra se faire autant que possible dans le respect de ses grands principes. Maintenant, on va voir des attitudes à prendre devant quelques situations pratiques. Devant l'angoisse, l'attitude la plus adaptée est le plus souvent une attitude souple d'écoute bienveillante.

Écouter la souffrance du patient, des fois, rien que le fait d'écouter, le patient est soulagé et son angoisse peut diminuer. Centrer l'écoute sur les préoccupations du malade. « Oui, je comprends.

» « Oui, je sais. » « Oui, vous avez mal. » « Oui, vous êtes angoissé.

» « Oui, je comprends. » Essayez de centrer vos préoccupations sur la souffrance du malade. Associer à une attitude de réassurance et d'explication des symptômes.

En même temps que vous citez la souffrance du patient, les symptômes qu'on rapporte au patient, vous essayez de le rassurer et vous essayez de lui expliquer ses symptômes. Certains médecins ont un tempérament actif et volontaire et vont être un petit peu plus directifs. Ils vont prendre ce qu'on appelle l'image du médecin-sauveur, donc chose qu'il ne faut pas faire.

Ils sont sous-tendus par une tentative d'identification directe du malade au médecin. « Soyez fort comme moi. » « Faites comme moi.

» « Regardez-moi comment je fais. » Donc là, il ne faut pas faire cette attitude-là. Ce type d'attitude donne des résultats inconstants, parfois négatifs.

Face à l'agressivité, l'agressivité, c'est des réactions qu'on va trouver même chez les autres patients qui ne sont pas des malades mentaux. Donc, ce n'est pas uniquement l'apanage des malades mentaux. Certains médecins tolèrent mal les revendications agressives de leurs patients.

Ces réactions agressives sont à éviter car elles entraînent une escalade dans l'agressivité et une rupture de la relation thérapeutique. Donc, si le patient est agressif et vous répondez par l'agressivité, vous entrez dans une escalade de l'agressivité. L'agressivité crée l'agressivité.

Et bien sûr, quand il y a l'agressivité entre médecin et malade, il y a rupture de la relation thérapeutique. L'attitude la plus adaptée consiste, dans la mesure du possible, à reconnaître et nommer l'émotion du patient. « Je sais que vous êtes en colère, je sais que vous êtes angoissé, je sais que vous n'aimez pas ça, je sais... » Donc, essayez de nommer l'émotion du patient.

Ne pas refuser le principe du dialogue et écoutez le patient. L'hypochondrie, c'est une crainte ou une croyance d'être atteint d'une maladie sérieuse fondée sur l'interprétation erronée de certaines sensations ou symptômes physiques, même si on n'en trouve aucune affection médicale. Donc, devant un symptôme, par exemple, une douleur abdominale, le patient va croire qu'il a un cancer abdominal.

L'hypochondriac confrontera le médecin à l'impuissance thérapeutique. Donc, il va venir la prochaine fois vous voir, vous allez prescrire un traitement, il va revenir vous dire qu'il n'a pas été amélioré sur ce traitement. Vous allez changer encore le traitement, vous allez demander des bilans et il va revenir et il va vous dire qu'il va de plus en plus mal.

Donc, il va vous mettre dans une situation d'impuissance. Le médecin évitera toute médication inutile qui pérenniserait les troubles, voire les aggraverait. Donc, ça ne sert à rien de donner un

autre traitement, de donner un autre bilan.

Le patient va se dire qu'il a quelque chose de grave, que vous n'êtes pas encore arrivé à traiter, que vous n'êtes pas encore arrivé à trouver le bon traitement ni le bon examen à faire pour bien diagnostiquer sa maladie. Alors, les patients séducteurs qui ont une personnalité histrionique, ce sont des patients influençables, dépendants, qui se moulent au corps médical avec une plasticité étonnante. Donc, ils sont trop dépendants du corps médical.

Guérir pour eux pourrait alors signifier une rupture de ce lien affectif. Ce phénomène favorise les hospitalisations abusives et des bénéfices secondaires. Donc, continuez à venir à vous voir.

Le médecin doit avoir pour objectif de prévenir cet engrenage. Donc, il doit casser cette boucle pour éviter les hospitalisations abusives. L'effet placebo.

Le placebo désigne toute substance pharmacologique inerte susceptible de modifier l'état du malade, soit en l'améliorant, on parle d'effet placebo positif, soit en déclenchant des effets indésirables, on parle d'effet placebo négatif ou effet nocebo. L'effet placebo, il dépend de nombreux facteurs. Il dépend de la nature des symptômes pour lesquels il est administré.

Il dépend de la présentation du placebo, les modalités de sa prise, le nombre et la couleur des comprimés. Il dépend de la personnalité du sujet, de l'influence du prescripteur. Les sujets placebo répandeurs sont plutôt des sujets sociables, rapidement influençables, qui sont dans l'attente d'une amélioration.

Le prescripteur influence la réponse au placebo. Donc, c'est en fonction de votre savoir-faire et de votre savoir-être. Si vous arrivez à convaincre le patient qu'il va aller mieux, donc même si vous lui donnez un placebo, il va s'améliorer.

La relation positive au médecin favorise, bien sûr, la réponse au placebo et par extension, il va favoriser la réponse au traitement actif. Une relation médecin-malade de qualité est un facteur qui favorise l'observance du traitement médicamenteux, surtout pour les maladies au long cours. L'ensemble de ces enjeux, dont la complexité est perceptible, justifie pour le moins une formation psychologique du médecin.

Dans une société en pleine mutation, pour ce qui est de la relation médecin-malade, cette formation permettra au médecin d'éviter l'utilisation inadaptée et parfois pathogène des dimensions psychologiques. Donc, ça nous permettra de comprendre les réactions du patient et ça nous permettra de faire face aux différents types de réactions du patient, de jouer son rôle apaisant et réorganisateur à travers la qualité de la relation établie avec le patient et son entourage. Et je vous remercie.